Клинические рекомендации

Травма гортани

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**R04.1** — Кровотечение из горла **S10.0** — Ушиб горла **S10.1** — Другие и неуточненные поверхностные травмы горла **S11.0** — Открытая рана, затрагивающая гортань и трахею
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 19.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/813_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология 3

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 5

3.1 Ларингоскопия 5

3.2 Видеоларингоскопия и микроларингоскопия 5

3.3 КТ шеи и пищевода 6

3.4 Анализы, пульсоксиметрия, посев 6

4. Лечение 6

4.1 Консервативное лечение 7

4.2 Обезболивание 8

4.3 Антибиотики, столбняк, гемостатики 9

4.4 Хирургическое лечение 10

4.5 Хирургическая обработка раны 10

4.6 Переломы и разрывы гортани 11

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 12

5.1 Показания к госпитализации 12

5.2 Реабилитация и наблюдение 12

6. Источник и актуальность 12

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 13

1. Основные положения

- Травма гортани опасна для жизни: главное — проходимость дыхательных путей, дыхательная недостаточность может нарасти позже из-за отёка и гематомы. Всех пострадавших госпитализируют для наблюдения, при лёгкой травме **24–48 часов**, особенно детей.
- Значительный или нарастающий отёк гортани — трахеотомия в сознании. Интубации по возможности избегают: трубка может усугубить повреждение; если интубируют — трубкой на размер меньше, с иммобилизацией шейного отдела позвоночника.
- Обследование: ларингоскопия и видеоларингоскопия всем, пальпация шеи (эмфизема), КТ шеи (с контрастом при подозрении на повреждение сосудов, пищевода), исключить повреждение шейного отдела позвоночника. МРТ при осколочных и пулевых ранениях нельзя.
- Без смещения хрящей и нарастания дыхательной недостаточности — консервативно: противоотёчная терапия, ингаляции будесонида и кислород, голосовой покой, антирефлюксные препараты; при открытой ране — антибиотики и профилактика столбняка.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. открытая рана, затрагивающая гортань: повреждение гортани снаружи или изнутри с нарушением целостности кожи и слизистой, целостности и функции органа;
2. ушиб глотки, гортани: закрытое повреждение тупым предметом без нарушения целостности кожи и слизистой, с разрывом мелких сосудов и кровоизлиянием.

2.2 Этиология

Причины

1. открытые раны: чаще ножевые и огнестрельные;
2. тупая наружная травма: удар предметом или кулаком, авария, спорт, попытка удушения — с переломом хрящей и подъязычной кости, отрывом гортани, разрывом голосовых складок;
3. внутренняя травма с кровотечением: чаще ятрогенная (интубация, ИВЛ, эндоскопия, операции) или инородное тело (рыбья кость, пища, зубные протезы);
4. кровотечение из горла: также злокачественные опухоли.

Возможные повреждения

1. перелом подъязычной кости, хрящей гортани и трахеи;
2. отрыв гортани от трахеи или подъязычной кости;
3. разрыв голосовых складок, смещение черпаловидных хрящей, парез гортани;
4. кровоизлияния и гематомы со сдавлением дыхательных путей.

У детей гортань из гибких хрящей, устойчива к перелому, но подслизистый слой слабо прикреплён к надхрящнице: выше риск массивного отёка и гематомы, даже малая травма может повредить слизистую и заднюю стенку трахеи.

2.3 Классификация

1. по этиологии: механические (в том числе ятрогенные), огнестрельные, химические, термические;
2. по механизму: наружные, внутренние, тупые, острые (колотые, резаные);
3. по кожной ране: открытые, закрытые;
4. по проникновению в полость гортани: проникающие, непроникающие;
5. изолированные и сочетанные.

Тяжесть травмы гортани по Schaefer

Группа	Повреждения
1	незначительные эндоларингеальные гематомы без повреждения слизистой и хрящей
2	отёк, гематома, незначительные повреждения слизистой без обнажения хряща или перелом хряща без смещения
3	массивный отёк, большие разрывы слизистой, обнажённый хрящ, перелом хряща со смещением или неподвижность голосовых складок
4	как в 3 группе плюс серьёзные повреждения передних отделов, нестабильные переломы, две и более линии перелома или тяжёлые травмы слизистой
5	полный отрыв гортани от трахеи

Огнестрельные ранения гортани: касательные без проникновения в полость; проникающие слепые или сквозные без повреждения окружающих структур; проникающие с повреждением пищевода, сосудисто-нервного пучка, позвоночника. Травмы глотки делят на наружные и внутренние, по причине, повреждающему фактору (тупые, колото-резаные, огнестрельные, химические и термические ожоги, инородные тела), отделу глотки и распространённости.

2.4 Клиническая картина

Симптомы

1. нарушение дыхания — главный симптом, может развиться сразу или позже из-за отёка, инфильтрации, гематомы;
2. дисфония, афония — при всех травмах, особенно голосового отдела;
3. боль: от дискомфорта до выраженной;
4. дисфагия при повреждении входа в гортань, парезе, патологии глотки;
5. кашель — при инородном теле, внутреннем кровотечении, остром воспалении;
6. подкожная эмфизема шеи — проникающее повреждение гортани или трахеи, может распространяться на грудь и средостение;
7. кровотечение угрожает жизни при повреждении крупных сосудов, аспирации крови или гематоме, суживающей просвет;
8. проникающая рана: на выдохе пузырящийся кровавой пеной воздух, на вдохе засасывание воздуха с шипением;
9. внутренняя травма: кровохарканье, кровь изо рта;
10. повреждение гортанных нервов: парез гортани.

Внутренние повреждения глотки протекают легче наружных: пациент указывает место и причину (эндоскопия, еда, интубация); сразу боль при глотании, нарушение глотания, возможно кровотечение и нарастание отёка.

У детей дыхательные нарушения развиваются быстрее и тяжелее; тупая травма гортани и трахеи может протекать неявно и имитировать обычные респираторные болезни.

3. Диагностика

Критерии диагноза

1. анамнез, не исключающий травму шеи; после травмы боль, затруднение дыхания, изменение голоса, затруднение глотания, кровотечение, одышка;
2. стридор на вдохе — обструкция надскладкового отдела (отёк, гематома); на выдохе — подскладкового отдела, трахеи; двухфазный — повреждение голосовой щели;
3. рана или отёк и гематома шеи, подкожная эмфизема;
4. исчезновение крепитации («щелчка») гортани при смещении в стороны;
5. на выдохе из раны пузырящаяся кровавая пена, кровь в слюне;
6. видеоларингоскопия: отёк, кровоизлияние, гематома, разрыв слизистой, деформация голосовой щели, нарушение подвижности складок;
7. КТ: деформация контуров шеи, эмфизема, перелом хрящей, изменения просвета, раневой канал, инородные тела, нарушение пассажа контраста при ранении глотки и пищевода.

Выясняют механизм травмы, время после неё, жалобы и их динамику; если пациент без сознания — у родственников или сопровождающих. Первичная оценка — по принципам расширенного жизнеобеспечения при травме (ATLS).

3.1 Ларингоскопия

Показания

1. все пациенты при поступлении в стационар.

Непрямая ларингоскопия зеркалом обязательна пациентам **12 лет и старше**; у дошкольников и младших школьников часто невозможна из-за эмоциональной лабильности и глоточного рефлекса.

Всем: оценка раны — локализация, размеры, глубина, края, отношение к сосудам и нервам; исключить инородные тела, наружное или горловое кровотечение, повреждение дыхательных путей.

Всем: пальпация шеи и грудной клетки для исключения подкожной эмфиземы.

3.2 Видеоларингоскопия и микроларингоскопия

Показания

1. все пациенты: гибкие и ригидные эндоскопы с углом обзора 70° и 90°.

Оценивают слизистую, отёк, голосовую щель и подвижность складок, подскладковый отдел и трахею; при ране — возможен ретроградный осмотр. У детей предпочтительна фиброларингоскопия.

Показания

1. 2–5 группы тяжести по Schaefer: уточнение диагноза, выбор метода и объёма лечения.

После обеспечения стойкой проходимости дыхательных путей: перстнечерпаловидное сочленение, слизистая, хрящевой каркас.

При наличии оборудования всем: ларингостробоскопия и электромиография гортани — объективная оценка подвижности голосовых складок.

Показания

1. дети с травмой гортани: УЗИ гортани в дополнение к ларингоскопии.

Видны подвижность складок и черпаловидных хрящей, их асимметрия, утолщение складок, переломы щитовидного хряща, гематомы.

3.3 КТ шеи и пищевода

Показания

1. подозрение на повреждение сосудов: КТ шеи, в том числе с внутривенным контрастированием.

Рентгенография мягких тканей шеи малоинформативна: видны только отёк, эмфизема, перелом подъязычной кости.

КТ показывает

1. хрящевой каркас гортани и подъязычную кость;
2. раневой канал и инородные тела;
3. вовлечение сосудов шеи;
4. распространённость эмфиземы.

Показания

1. подозрение на повреждение глотки, пищевода: КТ пищевода с пероральным контрастированием при поступлении.

Показания

1. проникающее ранение гортани или глотки: эзофагоскопия для исключения повреждения пищевода.

При любой травме гортани исключают повреждение шейного отдела позвоночника; при его выявлении — немедленная консультация профильного специалиста.

МРТ при осколочных и пулевых ранениях не выполняют: металлические инородные тела могут сместиться.

3.4 Анализы, пульсоксиметрия, посев

Показания

1. кровопотеря или подозрение на неё: общий анализ крови;
2. все пациенты: коагулограмма.

Дети с признаками стеноза: пульсоксиметрия — степень дыхательной недостаточности и необходимость кислорода.

Ранение гортани или глотки: посев отделяемого раны с определением чувствительности.

---

4. Лечение

Принципы при любой тактике

1. восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей;
2. остановка кровотечения, восполнение кровопотери;
3. профилактика травматического шока;
4. противоотёчная, антибактериальная, дезинтоксикационная, противовоспалительная терапия.

Первоочередное внимание — проходимости дыхательных путей: своевременно распознать обструкцию или угрозу её и предотвратить аспирацию.

Лечение по тяжести травмы (Schaefer)

Группа	Тактика
1	обязательна гибкая эндоскопия гортани; обычно медикаментозно, без операции: системные кортикостероиды, антибиотики, антирефлюксные, увлажнение воздуха, голосовой покой

Группа	Тактика
2	дополнительно прямая ларингоскопия и эзофагоскопия; наблюдение в динамике, повреждения могут прогрессировать; иногда трахеотомия; та же медикаментозная терапия
«2» (так в КР, по смыслу 3)	прямая ларингоскопия или эзофагоскопия в операционной; часто трахеотомия, как правило, операция при разрыве передней комиссуры, обширных рваных ранах, разрывах и неподвижности складок, обнажении хряща, переломах со смещением, подвывихе черпаловидного хряща
«3» (по смыслу 4)	обязательны прямая ларингоскопия и эзофагоскопия; всегда трахеотомия; при операции — стент
«4» (по смыслу 5)	тяжёлая дыхательная недостаточность: эндоскопия откладывается до восстановления проходимости; повреждения на уровне перстневидного хряща, перстнетрахеального соединения — трахеотомия (может быть сложной), ларинготрахеопластика

4.1 Консервативное лечение

Показания

1. ссадины и поверхностные повреждения кожи;
2. тупые наружные и внутренние травмы с отёком, ссадинами, гематомами без повреждения хрящей или без смещения отломков;
3. нет нарастания дыхательной недостаточности и гнойного воспаления в тканях шеи.

Ссадины обрабатывают антисептиком и закрывают асептической повязкой; при стабильном состоянии — симптоматическая терапия.

Инфицированная рана или высокий риск инфицирования: антисептики — бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний, повидон-йод, хлоргексидин, у взрослых и детей; до разрешения инфекции или эпителизации.

Показания

1. признаки стеноза верхних дыхательных путей: ингаляции лекарственных препаратов и кислорода.

После травмы и при эвакуации — прохладный кислород через маску.

Будесонид ингаляционно

1. взрослые: раствор 1,0 мг 1–2 раза в день, 5–8 процедур;
2. дети **старше 6 месяцев**: суспензия 0,25–0,5 мг 1–2 раза в день, 5 процедур.

Ингаляция обычно 10 минут, между ингаляциями разных препаратов около 30 минут.

Открытая и закрытая травма: противоотёчная терапия — парентерально системные кортикостероиды и диуретики.

Голосовой режим: не кричать и не шептать **не менее 2 дней**; полный голосовой покой **1–2 суток**, затем ограничение нагрузки. Исключить острую, солёную, горячую, холодную пищу, алкоголь, курение.

Рана или воспаление слизистой гортани и гортаноглотки: препараты для лечения язвенной болезни и ГЭРБ (A02BX) — защита от желудочного содержимого.

Ранение гортаноглотки, пищевода, выраженный отёк гортаноглотки, невозможность питаться естественным путём: назогастральный зонд и парентеральное питание.

4.2 Обезболивание

Показания

1. все пострадавшие: анальгетики и НПВП, отдельно или в комбинации, в том числе НПВП с парацетамолом, метамизол натрия; также после операции.

Ограничения у детей

1. ибупрофен: с 3 месяцев — свечи и суспензия, с 6 лет — таблетки, с 12 лет — капсулы;
2. кетопрофен: с 6 лет — гранулы, с 15 лет — парентерально;
3. метамизол натрия: амбулаторно не применять; в стационаре — только если нет других разрешённых детям анальгетиков.

Обезболивание у взрослых

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол	1 г в/в инфузия 15 мин	4 ч	4 г	5–7 сут
Диклофенак	75 мг в/м (в КР «75 мл»)	12 ч	150 мг	2 сут
Кеторолак	30 мг в/в, в/м	6 ч	60–90 мг	2 сут
Кетопрофен	100 мг в/в, в/м	12 ч	200 мг	не более 2 сут
Лорноксикам	8 мг в/в, в/м	12 ч	16 мг	1–7 сут
Декскетопрофен	50 мг в/в, в/м	8–12 ч	150 мг	2 сут
Метамизол натрия	500–1000 мг в/в, в/м	8–12 ч	2 г	1–5 сут

Обезболивание у детей

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Парацетамол в/в	инфузия 15 мин: более 50 кг — 1000 мг; 10–50 кг — 15 мг/кг; менее 10 кг — 7,5 мг/кг; новорождённым до 1 месяца противопоказан	4 ч	более 50 кг — 4 г; 33–50 кг — менее 60 мг/кг, не более 3 г; 10–50 кг — менее 60 мг/кг, не более 2 г; менее 10 кг — менее 30 мг/кг	5–7 сут
Парацетамол внутрь, суспензия	10–15 мг/кг	6 ч	не более 60 мг/кг	3–5 сут
Парацетамол ректально	10–14 лет 350–500 мг; 5–10 лет 250–350 мг; 3–5 лет 150–200 мг; 1–3 года 100–150 мг; 3–12 мес 50–100 мг	4–6 ч	менее 60 мг/кг	до 5 сут
Ибупрофен внутрь	старше 6 лет 200–400 мг; 4–6 лет 150 мг; 1–3 года 100 мг; 6–12 мес 50 мг; 3–6 мес 50 мг	8 ч; 6–8 ч (в таблице КР не сопоставлены с возрастами построчно)	12–17 лет 1 г; 6–12 лет 800 мг; 4–6 лет 450 мг; 1–3 года 300 мг; 6–12 мес 200 мг; 3–6 мес 150 мг	4 сут
Ибупрофен ректально	3–9 мес 60 мг; 9–24 мес 60 мг	3–9 мес 8 ч; 9–24 мес 6 ч	3–9 мес 180 мг; 9–24 мес 240 мг	не более 3 сут
Кетопрофен в/в, в/м	с 15 лет 100 мг	12 ч	200 мг	не более 2 сут

Препарат	Разовая доза	Интервал	Максимум в сутки	Длительность
Кетопрофен внутрь, гранулы	старше 6 лет 40 мг	8 ч	120 мг	не более 2 сут
Метамизол натрия	с 15 лет 500–1000 мг в/в, в/м; 3 мес – 1 год 50–100 мг/10 кг в/м	8–12 ч	с 15 лет 2 г	3 сут

4.3 Антибиотики, столбняк, гемостатики

Показания

1. открытая рана, осложнения, сочетанные повреждения: системная антибактериальная терапия (близость ротоглотки повышает риск инфекции).

Цефалоспорины III поколения (цефотаксим или цефтриаксон) и инфузионно метронидазол; при распространении эмфиземы в средостение и риске медиастинита — меропенем. Доза и длительность — по клинической ситуации.

Антибиотики при травмах шеи

Препарат	Разовая доза	Кратность	Длительность
Цефотаксим в/в, в/м	взрослые и дети старше 12 лет (более 50 кг): 1 г; дети до 12 лет (менее 50 кг): 50–75 мг/кг; новорождённые: 25 мг/кг	2 раза в сутки	7–10 дней
Цефтриаксон в/в, в/м	взрослые 1–2 г; дети 2 мес – 12 лет: 20–100 мг/кг; новорождённые (с 15 дней), грудные и младшего возраста: 20–80 мг/кг	1 раз в сутки	7–10 дней
Метронидазол в/в капельно, 5 мл/мин	старше 12 лет: 500 мг; до 12 лет: 7,5 мг/кг	3 раза в сутки	7–10 дней

Повреждение кожи и слизистой с загрязнением раны: экстренная профилактика столбняка как можно раньше, **до 20-го дня** после травмы — столбнячный анатоксин, противостолбнячный иммуноглобулин человека или сыворотка по инструкции.

Показания

1. наружное кровотечение или кровотечение из горла: гемостатические средства; небольшие наружные — давящая асептическая повязка.

Дозы

1. этамзилат: взрослым 250–500 мг в/в или в/м, затем по 250 мг каждые 4–6 ч; детям 10–15 мг/кг в сутки в 3–4 приёма, 5–10 дней;
2. транексамовая кислота: в/в медленно 1 мл/мин (50 мг/мин); взрослым 10–15 мг/кг каждые 6–8 ч, детям старше 1 года 20 мг/кг в сутки — до остановки кровотечения;
3. аминокапроновая кислота в/в капельно: взрослым 4–5 г за первый час, затем по 1 г/ч не более 8 ч, максимум 30 г в сутки; детям 100 мг/кг за первый час, затем 33 мг/кг/ч, максимум 18 г/м^2 в сутки; курс 3–14 дней.

4.4 Хирургическое лечение

Показания

1. стеноз гортани в стадии декомпенсации;
2. кровотечение;
3. открытая, загрязнённая рана, инородные тела, нежизнеспособные ткани, потеря мягких тканей, дефицит кожи;
4. выраженная или нарастающая эмфизема;
5. перелом хрящей гортани со смещением, суживающим просвет.

Показания

1. значительный, особенно нарастающий отёк гортани: трахеотомия в сознании.

На месте травмы допустимо ввести трубку через рану в гортань или трахею, коникотомия или крикотиреоидотомия с последующей заменой на типичную трахеостому с подшиванием трахеи к коже. По возможности избегают интубации. Детям трахеотомию — только под комбинированным ингаляционным наркозом.

Тяжёлые ранения шеи — тактика контроля повреждений (damage control surgery): сокращённая первая операция, окончательное восстановление после стабилизации.

Первый этап

1. устранение асфиксии: интубация, типичная или атипичная трахеотомия;
2. остановка кровотечения: сосудистый шов, перевязка, тугая тампонада, временное протезирование сонных артерий;
3. защита тканей шеи от содержимого полых органов: швы или мазевые тампоны;
4. иммобилизация шеи воротником Шанца при ранении позвоночника.

Интубационная трубка — на размер меньше расчётной, с сохранением иммобилизации шейного отдела.

Показания

1. кровотечение из горла: тампонада раны, коагуляция сосуда, сшивание раны;
2. массивное некупируемое: эндоваскулярная окклюзия или перевязка наружной сонной артерии;
3. обширное повреждение гортани с неясным источником: перевязка верхней щитовидной или наружной сонной артерии после трахеотомии ниже места повреждения.

Кровотечение останавливают экстренно для профилактики геморрагического шока: давящая повязка и гемостатики, при неэффективности — лигатуры на сосуд в ране.

4.5 Хирургическая обработка раны

Объём по типу раны

1. поверхностная: обработка, санация, первичный шов;
2. глубокая с повреждением мягких тканей: рассечение, иссечение, восстановление структур, дренирование, шов, противовоспалительная и антибактериальная терапия;
3. обширные скальпированные и размозжённые: первичная обработка, первичная или отсроченная пластика кожи, восстановление структур, дренирование, по показаниям трансфузия.

Обработка ран гортани — экономная и ранняя, слизистая максимально сохраняется. Раны гортани и трахеи **до 0,5 см** можно не ушивать и лечить дренированием.

Первичную хирургическую обработку не проводят

1. поверхностные раны, царапины, ссадины;
2. раны с расхождением краёв **менее 1 см**;
3. множественные мелкие раны без повреждения мышц и фасций;
4. колотые раны без повреждения органов, сосудов, нервов.

Туалет раны, края можно свести пластырем.

Все раны дренируют доступными способами до прекращения отделяемого.

При инфицировании раны и гнойных осложнениях рану не ушивают до их купирования.

4.6 Переломы и разрывы гортани

Любые переломы хрящей гортани со смещением фиксируют. Сроки спорны: одни авторы оперируют в первые **24–48 часов**, другие откладывают на неделю и более до уменьшения отёка — решают индивидуально.

Показания

1. разрыв слизистой двух и более анатомических областей, свободного края голосовых складок, переломы хрящевого каркаса: тиреоидотомия.

Слизистую восстанавливают, раны складок ушивают рассасывающимся швом 5/0 или 6/0; открытые хрящи закрывают. Перелом **более чем в 3 мм** от передней комиссуры — всё равно срединная тиреоидотомия.

Смещённые черпаловидные хрящи восстанавливают по степени повреждения; изолированные рваные раны укрывают слизистой.

Проникающее ранение с повреждением хрящей без значительного смещения: ларинготрахеопластика местными тканями после типичной трахеотомии; при необходимости наружный и эндоскопический доступ, в просвет на несколько дней — пальчиковый обтуратор.

Ларинготрахеостома при проникающем ранении

1. значительное разрушение и смещение хрящей;
2. разрывы в области передней комиссуры;
3. выраженная рубцовая деформация просвета.

В первые дни — тампон по Микуличу с мазью на основе хлорамфеникола, затем силиконовый протез. Оскольчатые переломы часто требуют стента и наружной фиксации; при стабильных переломах с минимальным повреждением слизистой стентирования избегают.

Перелом подъязычной кости с отрывом гортани: ларингогиоидопексия; отрыв гортани от трахеи: трахеоларингопексия (низкий трахеотомический разрез — трахея втягивается за грудину). Отрыв гортани обычно сопровождается пневмотораксом — его выявляют и лечат.

Хирургическая обработка и манипуляции в гортани — под местными анестетиками с учётом раны, боли и аллергоанамнеза.

Общая восстановительная диета, полноценная по составу, кроме пациентов с заболеваниями, требующими коррекции диеты (сахарный диабет и другие). С зондом или гастростомой — энтеральное или парентеральное питание.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Показания

1. все пациенты с травмой гортани и глотки: наблюдение за проходимостью дыхательных путей.

Лёгкие травмы, которые могут прогрессировать (отёк, гематома), — стационар **24–48 часов**, особенно дети.

У детей риск кардиогенного шока

1. брадикардия, аритмия;
2. падение артериального давления;
3. остановка сердца.

Небольшие непрогрессирующие гематомы при целой слизистой обычно рассасываются, большие или нарастающие могут потребовать трахеотомии.

Все, кто оказывает помощь на догоспитальном и госпитальном этапах, должны знать признаки обструкции дыхательных путей и владеть навыками поддержания дыхания с защитой шейного отдела позвоночника; на всех уровнях должны быть возможности интубации, коникотомии, трахеотомии.

5.2 Реабилитация и наблюдение

1. после тупой травмы с повреждением гортани и после ларинготрахеопластики без ларингостомы или после её закрытия: повторный осмотр оториноларинголога в поликлинике, при нарушении голоса — фониатр;
2. после ларинготрахеопластики с формированием ларингостомы: наблюдение оториноларинголога стационара.

Пациентам с открытой раной шеи и сформированной ларингостомой — наблюдение оториноларинголога стационара.

Повторный осмотр оториноларинголога **через 1 месяц**, затем **раз в 3 месяца** в течение года — выявить показания к реконструктивной операции: видеоларингоскопия, ларингостробоскопия, по показаниям функция внешнего дыхания. Сроки деканюляции и восстановления просвета — индивидуально.

Профилактика ятрогенной травмы при ИВЛ, ЭГДС, бронхоскопии: интубация и эндоскопия максимально аккуратно, при трудной интубации — видеоларингоскоп. Специфической профилактики других травм гортани и глотки нет.

Факторы неблагоприятного исхода операции

1. системные: пожилой возраст, иммунодефицит, кахексия, инфекция, онкологический процесс, нарушения углеводного обмена, коллагенозы;
2. местные: повреждение пищевода, сосудисто-нервного пучка, позвоночника, флегмона шеи, медиастинит, повторная травма, инфекция, инородные тела.

При первичной пластике и восстановлении просвета грубой деформации обычно нет, но травмы гортани и трахеи часто инвалидизируют и могут потребовать повторных реконструктивных операций.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Травма гортани»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 19.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года

Код в рубрикаторе	813_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 3 тактика по тяжести травмы описана для групп «1, 2, 2, 3, 4», а классификация Schaefer в разделе 1.5 содержит 5 групп: нумерация в лечебном разделе сдвинута. На странице группы подписаны так, как в КР, с пометкой о соответствии по смыслу.
- Таблица 1: разовая доза диклофенака записана как «75 мл в/м» — по смыслу 75 мг.
- Таблица 2: для парацетамола внутривенно у детей максимальные суточные дозы заданы для пересекающихся весовых групп «33–50 кг» и «10–50 кг» с разными пределами (3 г и 2 г). Сверяйте с инструкцией.